Autos: 0800058-93.2024.8.12.0009
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Davi Lucca Tavares Araújo
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos, para sentença.

I. Relatório.

Davi Lucca Tavares Araújo, representado por Edna Tavares Lima, ajuizou a presente "ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" em face de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Costa Rica, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta na petição inicial que a parte autora encontra-se com 6 anos de idade e foi diagnosticada com miopatia congênita (CID10 G71.2), tendo a médica especialista receitado para o tratamento o insumo BiPAP (*Bi-level Positive Airway Pressure*) e máscara nasal.

Pugnou pela concessão de tutela provisória de natureza antecipada, deferida (p. 48-50).

No mérito, requereu a procedência dos pedidos para declarar a obrigação da parte ré no fornecimento do insumo BiPAP (*Bi-level Positive Airway Pressure*) e máscara nasal.

Fez os pedidos de estilo e juntou documentos (p. 13-39).

O Parecer Técnico do NAT foi favorável (p. 42-7).

Citada, a parte ré ofereceu resposta na forma de contestação.

O Estado de Mato Grosso do Sul (p. 63-4) não impugnou o pedido de fornecimento de aparelho BiPAP e acessórios.

Requereu (a) a não determinação do fornecimento do aparelho BiPAP por marca específica; (b) improcedência de eventual pedido de restituição e inversão do ônus da prova; (c) não condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios; e (d) que não seja fixada multa diária se determinada a execução forçada da obrigação.

No mais, formulou os pedidos de estilo.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

O Município de Costa Rica (p. 73-94) salientou que os insumos pretendidos pela parte autora não é um aparelho que a rede SUS tem disponível para os pacientes, não está padronizada na assistência farmaceutiva básica e é de alto custo.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais.

Houve impugnação (p. 104-13).

Instado, o Ministério Público emitiu parecer pela procedência dos pedidos (p. 129-36).

É o relatório.

Decido.

II. Fundamentação.

O feito está em ordem. Não há preliminares pendentes ou nulidades a sanar.

O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que não vislumbro a necessidade de produção de outras provas em audiência, estando suficientemente instruído para solução da causa.

Trato de ação de obrigação de fazer por meio da qual a parte autora pretende a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Costa Rica no fornecimento de BiPAP (*Bi-level Positive Airway Pressure*) e máscara nasal.

A postulante, com 6 (seis) anos de idade ao tempo do protocolo da petição inicial, foi diagnosticada com miopatia congênita (CID10 G71.2), motivo pelo qual a médica especialista receitou os insumos para tratamento.

Inicialmente, aponto que a Constituição Federal de 1988 erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental, estabelecendo em seu art. 196 ser um direito a todos, garantido pelo Estado, ao qual compete o desenvolvimento de políticas que visem à promoção da saúde, redução do risco de doenças e, caso esta já se tenha consolidado, ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para proteção e recuperação da saúde.

A judicialização das políticas públicas de saúde vem atingindo números elevados de ações e de custos, especialmente em função da prescrição de medicamentos não fornecidos pelo sistema. O SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, é compelido à prestação de serviços de saúde, sob os princípios da universalidade e integralidade.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

O art. 2º e parágrafo 1º da Lei nº 8.080/90 dispõe o seguinte:

> Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
>
> § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Em relação à obrigação do Estado de fornecer medicamento *off label*, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 106, fixou tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento[1].

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral, acrescentou requisitos outros para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS:

> 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
>
> 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
>
> 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º,

[1] REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018 (Info 625)


Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

> incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024.

Ao seu lado, o item IV da tese fixada no Tema 1234 trata da análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS, sendo complementar ao Tema 6.

> 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.
>
> 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
>
> 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
>
> 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
>
> 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios


Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

> clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. STF - RE: 1366243 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024

Além disso, foi editada a súmula vinculante 60, estabelecendo que o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Dessa forma, o Tema Repetitivo 106 do STJ está superado (*overruling*) pelas teses fixadas nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, em especial porque o sistema brasileiro de precedentes, consolidado nos artigos 926 e 927 do CPC, impõe a aplicação imediata das teses definidas pelo STF, independentemente do trânsito em julgado, como método de tutela da segurança jurídica e igualdade, salvo modulação de efeitos[2].

O Parecer Técnico nº 0343/2024 emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, foi favorável aos pedidos pois disponibilizados pelo SUS, mas não padronizado pela ANVISA (p. 42-7).

O artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil determinou a obrigatória observação por juízes e tribunais das decisões prolatadas em os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

O artigo 489, parágrafo 1º, inciso VI, do mesmo Diploma, assinala que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O dispositivo último incorporou expressamente o instituto da *distinguishing* possibilitando ao julgador afastar o precedente vinculante quando as situações concretas apontarem para caminho diverso daquele outrora sedimentado.

Na doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

> O precedente pode versar sobre matéria processual, relacionada à admissibilidade da ação, ou de mérito. Nas hipóteses de precedentes obrigatórios, o julgador deve verificar a pertinência da sua aplicação ao caso

[2] TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10332066820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

> concreto, isto é, se o caso que está sob julgamento assemelha-se àqueles que deram origem ao precedente, que versará sempre sobre uma questão jurídica. Caberá ao julgador, ao aplicar a tese jurídica adotada no precedente obrigatório, a) verificar se o caso *sub judice* é assemelhado ou se existe distinção entre a situação concreta e as que deram ensejo ao precedente e b) verificar se o entendimento não ficou superado (art. 489, § 1º VI). Somente se a situação não for distinta, mas assemelhada à anteriormente examinada, é que o precedente será aplicado, com eficácia obrigatória. Constatando o juiz a distinção ("distinguishing"), ele poderá não aplicar a tese jurídica, fundamentando a sua decisão na distinção dos casos. Mesmo em casos de distinção de situações, o juiz, também em decisão fundamentada, pode concluir que a tese jurídica, embora versando sobre outra situação, pode ser também aplicada àquela, entendendo que, também para aquela outra situação, a solução jurídica indicada no paradigma é a melhor. Em síntese, o juiz deve confrontar o caso concreto com aqueles que deram origem à tese jurídica, para verificar se são análogos ou distintos. Se análogos, deve aplicar a tese jurídica, nos casos de precedentes vinculantes; se não, fica livre para decidir conforme o seu convencimento, podendo nã aplicar a tese, se entendê-la inadequada, dada a distinção de situações; ou aplicá-la se, apesar da distinção, entender que essa é a melhor solução. Direito processual civil – Esquematizado – 11. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.

Com efeito, é cediço que a tutela e concretização dos direitos infantojuvenis deve ter por norte a doutrina da proteção integral e a absoluta prioridade na efetivação dos direitos e garantias reservados à criança e ao adolescente. Tratam-se de postulados de interpretação e orientação extraídos da Constituição e do ECA que visam alcançar o real significado dos demais princípios e regras que compõem o sistema protetivo em questão.

A propósito, transcrevo o art. 227, *caput*, da Constituição e o art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente:

> Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
>
> Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

Especificamente quanto à proteção e implementação do direito à saúde das crianças e adolescentes, previu no parágrafo 1º do artigo 227 da Carta Republicana:

> § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

Ao seu lado, o art. 7º da Lei nº 8.069/90 reza que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Transcrevo, ainda, o art. 24 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU/1989), ratificada pelo Decreto Presidencial nº 99.710/90:

> Artigo 24
>
> 1) Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde. Os Estados Partes devem envidar esforços para assegurar que nenhuma criança seja privada de seu direito de usufruir desses serviços de cuidados de saúde.
>
> 2) Os Estados Partes devem garantir a plena aplicação desse direito e, em especial, devem adotar as medidas apropriadas para:
>
> - reduzir a mortalidade infantil;
>
> - assegurar a prestação de assistência médica e cuidados de saúde necessários para todas as crianças, dando ênfase aos cuidados primários de saúde;
>
> - combater as doenças e a desnutrição, inclusive no contexto dos cuidados primários de saúde mediante, *inter alia*, a aplicação de tecnologia prontamente disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água limpa de boa qualidade, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental;
>
> - assegurar que as mulheres tenham acesso a atendimento pré-natal e pós-natal adequado;
>
> - assegurar que todos os setores da sociedade, especialmente os pais e as crianças, conheçam os princípios básicos de saúde e nutrição da criança, as vantagens do aleitamento materno, da higiene e do saneamento ambiental, e as medidas de prevenção de acidentes; e que tenham acesso a educação pertinente e recebam apoio para a aplicação desses conhecimentos;
>
> - desenvolver assistência médica preventiva, orientação aos pais e educação e serviços de planejamento familiar.
>
> 3) Os Estados Partes devem adotar todas as medidas eficazes e adequadas para eliminar práticas tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da criança.
>
> 4) Os Estados Partes comprometem-se a promover e incentivar a cooperação internacional para buscar, progressivamente, a plena realização do direito reconhecido no presente artigo. Nesse sentido, devem ser consideradas de maneira especial as necessidades dos países em desenvolvimento.

O parágrafo único do artigo 100 da Lei n. 8.069/90, incluído pela Lei n. 12.010/09, trouxe uma série de princípios que embora alocados no capítulo que trata das medidas específicas de proteção, irradiam seus efeitos a todos os institutos do Estatuto. Dentre eles, ressalto o contido no inciso II:

> II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;

Sobre o tema, colaciono a doutrina de Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

> Devido à posição axiológica (valorativa) e à densidade de conteúdo, essa orientações de proteção e prioridade ocupam uma posição de destaque dentro dos princípios do direito da criança e do adolescente, denominando-se *metaprincípios*. [...] e assim são denominados porque extraídos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, representam postulados de interpretação para extração de significado dos demais princípios e regras que compõem o sistema protetivo dos direitos da criança e do adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado artigo por artigo: Lei nº 8.069/90, 12ª ed. São Paulo: Saraiva: 2021.

Diante desse cenário, mostra-se imperioso afastar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 6 e 1234 da Repercussão Geral, outorgando à parte autora a integral proteção do direito à saúde vindicado por meio da presente ação judicial.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem ao Poder Público a absoluta prioridade no atendimento às necessidades dos infantes, sobretudo quando envolve questão delicada como a proteção à saúde.

A doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta demandam a consideração de que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito, devendo as políticas públicas contemplar essa particularidade, proporcionando o reequilíbrio existente pelo fato de serem pessoas em especial condição de desenvolvimento.

Na hipótese dos autos, a parte autora, nascida em 24/1/2017, recebeu o diagnóstico de miopatia congênita (CID10 G71.2) quando tinha 4 (quatro) anos de idade (p. 18).

À p. 27 consta o relatório médico:

> Paciente DAVI LUCCA TAVARES ARAÚJO, portador de distrofia muscular congênita por deficiência de merosina tipo 1A, doença genética grave e incurável.
>
> Sono agitado, com apneias recorrentes, estridor inspiratório. Realizada Polissonografia, confirmando Grave Apneia Obstrutiva do sono .
>
> Solicito fornecimento URGENTE de Aparelho de Ventilação Não Invasiva- Bipap- bem como circuitos, interfaces e filtros, para uso diário durante todo o período noturno e também durante o sono durante o dia, a fim de reduzir os riscos de comorbidades para o quadro já muito grave da paciente em questão. (Vide laudo da Polissonografia em anexo)

Os documentos de p. 35-8 e 27 comprovam os insumos indicados para tratamento da condição de saúde da parte autora, sendo eles o aparelho BiPAP e máscara nasal.

Registro que o parecer do Núcleo Técnico foi favorável aos pedidos de insumos de acordo com a prescrição médica e sem distinção de marca (p. 42-7).

Os anseios buscados pela Constituição Federal para materialização



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

do princípio da proteção integral e da absoluta prioridade, encampados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, demandam prestigiar as orientações dadas pelos profissionais da saúde responsáveis pelo quadro clínico e intervenções terapêuticas as quais sujeita a parte autora.

Os valores consagrados pelos postulados fazem com que o direito à garantia à saúde da criança e do adolescente se sobreponha, na situação concreta específica, às formalidades e condicionantes constantes no Tema 6 e 1234 da Repercussão Geral.

A conclusão se estende aos insumos, os quais, como consignado pelos profissionais que cuidam da criança, são os que lhe permitem gozar do melhor padrão possível de saúde, na esteira do art. 24 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU/1989).

Colho na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

> REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA DEMANDA AFASTADA – TEMA 1234, DO STF – DIREITO À SAÚDE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – FÁRMACO COM REGISTRO CADUCO / CANCELADO NA ANVISA – CASO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA AFASTAR A TESE DEFINIDA NO TEMA 106, DO STJ – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DIREITO RECONHECIDO – MULTA DIÁRIA MANTIDA – POSSIBILIDADE DA SANÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO OBRIGATÓRIO NÃO CONHECIDO – APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. Não há falar em submissão da sentença ao reexame necessário nas hipóteses em que interposto recurso voluntário pela parte a quem aproveitaria a prerrogativa (art. 496, § 1.º, do CPC). No julgamento do Tema 793/STF reafirmou-se a solidariedade entre os entes da federação para figurar em demandas que versam sobre a promoção do direito à saúde, sendo garantido ao cidadão ajuizar a demanda em desfavor de quaisquer deles. No Tema 1.234/STF (RE 1366243), o Plenário do STF determinou, até definição da controvérsia, que as demandas judiciais relativas a medicamentos e procedimentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Em situações excepcionais, quando devidamente provada a necessidade de medicamentos ou suplementos sem registro na Anvisa, inclusive com registro caduco/cancelado, em se tratando do único meio para o tratamento satisfatório do paciente, admite-se o fornecimento gratuito pelo Poder Público, em respeito ao direito à saúde, com destaque para a necessidade de preservar o bem maior do ser humano (vida digna), em detrimento de posturas contrárias, até mesmo precedentes


Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

jurisprudenciais, a fim de assegurar o princípio fundamental da Constituição Federal consistente no mínimo existencial. É possível a fixação de multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, a qual tem a natureza de compelir o ente público ao cumprimento do comando da decisão judicial, a qual deve ser minorada se restar suficientemente demonstrada a exorbitância de seu valor. Nos termos da decisão do STF no Tema 1.002, o Estado ode ser condenado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública por ele instituída e quando vencido em ação em que ela representou o vencedor, de tal sorte que o valor seja utilizado exclusivamente para o aparelhamento do Órgão, proibido o rateio entre seus integrantes. TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800136-28.2023.8.12.0040, Porto Murtinho, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 19/09/2024, p: 20/09/2024.

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL – NECESSIDADE DE USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – MARCA ESPECÍFICA DIANTE DE ALERGIA CUTÂNEA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – RE 855178 RG/SE – TEMA 793 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONFUSÃO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSOS NÃO PROVIDOS. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos impõem aos entes públicos (art. 196, da CF) a responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento e medicamentos em favor de pessoa carente, obedecida a regra de repartição de competência estabelecida pela Suprema Corte no Tema 793. Comprovada a necessidade do uso de fralda descartável e de se tratar de criança carente e enferma, é dever do ente público o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. Indevida a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, sob pena de se configurar o instituto da confusão. TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800324-08.2019.8.12.0025, Bandeirantes, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 10/03/2020, p: 11/03/2020.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL – NECESSIDADE DEMONSTRADA - LIMITAÇÃO DO FORNECIMENTO ATÉ 24 MESES - DESCABIDA - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 196, DA CF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 4.º, INCISO II, DO CPC – ISENÇÃO DAS CUSTAS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. Em se tratando de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a remessa necessária deve ser conhecida de ofício (art. 496, § 3º, do CPC). Falta interesse recursal quando a matéria restou reconhecida pelo juízo de primeiro grau. O art. 196, da Constituição Federal prescreve que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. Comprovada a necessidade de utilização de fórmula infantil extensamente hidrolisada (Pregomin Pepti ou Aptamil Pró Expert Peptil), solicitada por médico e com



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

> parecer favorável do NAT, além do fato de que o paciente não possui condições econômicas de suportar os custos do tratamento, deve o Estado fornecê-lo, porquanto todas as pessoas têm direito à saúde. A limitação do fornecimento do alimento especial até que a criança complete 24 meses não se mostra razoável, uma vez que está condicionado a apresentação contínua de receituário médico, perdurando, assim, até que se mantenha a necessidade. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual n. 3.779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. TJMS. Apelação Cível n. 0800905-41.2019.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/04/2021, p: 04/05/2021.

Anoto que aplica-se a responsabilidade solidária quanto ao fornecimento dos insumos, haja vista que o NAT direcionou a obrigação aos réus[3].

*Ante o exposto*, sentencio o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo procedentes os pedidos formulados por Davi Lucca Tavares Araújo, representado por Edna Tavares Lima, em desfavor de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Costa Rica, para condenar a parte ré, solidariamente, no fornecimento dos insumos BiPAP (*Bi-level Positive Airway Pressure*) e máscara nasal, no prazo de 10 (dez) dias e durante todo o tratamento, sob pena de sequestro de verbas públicas.

Deixo de arbitrar multa por descumprimento, eis que o sequestro de verbas públicas, caso haja necessidade, mostra-se mais eficaz à obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente[4].

Confirmo os decisão que deferiu a tutela provisória.

Sem custas, nos termos do art. 24, inc. I, da Lei nº 3.779/2009.

Em atenção a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1.002)[5], condeno o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Costa Rica no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.500,00

---

[3] TJMS. Apelação Cível n. 0801679-87.2022.8.12.0012, Ivinhema, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/03/2023, p: 03/04/2023.

[4] TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800255-91.2020.8.12.0040, Porto Murtinho, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 18/07/2023, p: 19/07/2023

[5] I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Tese fixada no Tema 1002 do STF.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.

(dois mil e quinhentos reais), na proporção de 50% para cada, à luz do art. 85, parágrafos 2º e 8º, e art. 87, § 1º, todos do CPC[6].

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Aforados embargos de declaração, conclusos na fila correspondente.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, intime-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, consoante artigo 1.010, § 1º, do CPC.

Manejado recurso de apelação na forma adesiva, intime-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, na forma do artigo 1.010, § 2º, do CPC.

Observe-se eventual prazo em dobro, nos termos dos artigos 180, 183 e 186 do CPC.

Transitada em julgada, arquive-se os autos com as devidas anotações no sistema.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Costa Rica, data da assinatura digital.

Vinícius dos Anjos Borba
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

[6] Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável. Item 8 da edição nº 169 da ferramenta Jurisprudência em Teses do STJ.


Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 01/09/2025 às 19:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800058-93.2024.8.12.0009 e código BclXEdfy.